

Isquemia mesentérica · dor desproporcional

Dor abdominal intensa com exame físico ainda pobre = pense isquemia mesentérica. Tempo é intestino: angiotomografia e revascularização/ressecção precoces.

Tipos

Lembre - Tipos

Embolia arterial (FA), trombose arterial (aterosclerose), não oclusiva/NOMI (choque, vasopressores) e trombose venosa mesentérica (trombofilia). Cada uma tem nuance terapêutica.

Janela estreita: quanto mais tarde o diagnóstico, maior a necrose e a sepse.



Conduta

- Ressuscitação, ATB se necrose/perfuração suspeita, anticoagulação quando indicada
- AngioTC mesentérica = exame de escolha no estável
- Embolia/trombose: cirurgia/endovascular para restaurar fluxo + avaliar vitalidade
- Ressecar apenas alças inviáveis; second-look frequente

Pistas etiológicas

Tipo | Pista

Embolia | FA, IAM, sopro; início súbito

Trombose arterial | Claudicação abdominal prévia / aterosclerose

NOMI | UTI, baixo débito, drogas vasoativas

Venosa | Trombofilia, pancreatectomia, hipertensão portal

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Lactato normal não exclui isquemia precoce. Dor desproporcional + FA = angioTC, não 'analgésico e observar' até peritonite.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Isquemia mesentérica aguda: tríade clássica + dor desproporcional. Tempo é intestino — angiografia/TC e revascularização precoces.

Dor intensa com exame abdominal pobre no início é o alarme. Não espere peritonite para agir.

Triade classica

Isquemia mesenterica aguda

- 1 Dor abdominal intensa (desproporcional)
- 2 Doença cardíaca / embolígena (FA etc.)
- 3 Esvaziamento intestinal (vômito / diarreia)

Dor + coração + intestino (história)

Dor desproporcional

Atenção - Dor desproporcional

Exame ainda 'mole' com dor extrema + FA/aterosclerose = peça angioTC de vasos mesentéricos. Lactato! é tardio — normal não exclui.

Tipos

Tipo | Pista

Embólica arterial | FA, sopro; início súbito
Trombótica arterial | Aterosclerose; angina pós-prandial prévia
Venosa | Hipercoagulabilidade; mais insidiosa
Não oclusiva (NOMI) | Choque, vasopressores, baixo fluxo

Conduta

- Ressuscitação, ATB, anticoagulação se sem contraindicação (equipe)
- AngioTC; cirurgia se peritonite / necrose
- Revascularização (embolectomia, bypass, endovascular) + 2ª look se necessário
- Ressecção só do intestino inviável — preserve o viável

Crônica

Lembre - Crônica

Tríade crônica clássica: dor pós-prandial, medo de comer e perda ponderal — diferente da emergência oclusiva aguda.